

6657/ACPI/HLT/PROV/VII/2025

Jakarta, 09 Juli 2025

Kepada Yth:

DIREKTUR RS PRIMA HUSADA MALANG

Perihal: Permohonan Kerjasama untuk menjadi Rekanan RS PRIMA HUSADA MALANG

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, kami sampaikan bahwa kami bermaksud untuk menjalin kerjasama langsung dengan **RS PRIMA HUSADA MALANG**. PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) adalah asuransi kerugian nasional yang berdiri pada tanggal 12 Desember 2012 dengan izin usaha pada tanggal 06 Maret 2014 No. KEP-19/D.05/2014. PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) berfokus memberikan perlindungan terhadap kerugian harta benda dan perlindungan diri dari resiko kecelakaan dan sakit.

Sesuai dengan izin OJK, kami telah mendapatkan izin untuk memasarkan produk Asuransi Kesehatan yang merupakan salah satu produk unggulan kami. Produk ini memberikan solusi perlindungan bagi karyawan beserta keluarganya, jaminan manfaat yang diberikan meliputi: Rawat Inap dan Pembedahan, Rawat Jalan, Rawat Gigi, Persalinan dan Kacamata.

Terkait dengan pemasaran produk tersebut diatas, kami bekerjasama dengan *Third Party Administrator* (TPA) **PT Administrasi Medika (AdMedika)** dan **PT Medilink Digital Medika (Medilink)**.

Melalui surat ini kami sampaikan, kami bermaksud untuk memiliki kerjasama langsung dengan **RS PRIMA HUSADA MALANG**, dimana dalam kerjasama ini kami bertindak sebagai **Payor** / pihak yang membayar tagihan ke **RS PRIMA HUSADA MALANG**. AdMedika dan Medilink sebagai administrator yang melakukan pengelolaan klaim (*Claim Center* dan Penjaminan).

Kami berharap **RS PRIMA HUSADA MALANG** dapat mempertimbangan permohonan ini, sehingga kerjasama dapat terjalin dalam waktu dekat dimana Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) sebagai Payor.

Untuk menjalin kerjasama Rekanan, saya Rini Pratiwi sebagai Provider Relation dari PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI), dengan alamat email providerhealth1@cakrawalaproteksi.com, nomor telepon: 021-3971-6789 (Hunting) Ext. 167, handphone: 0812-1032-7614.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA



Rini Pratiwi
Provider Relation

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT.....
RUMAH SAKIT**

**DENGAN
PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA**

**TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI
PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA**

No.:
No.:/HLT-ACPI/PKS-PROV/.... /20242025

Perjanjian Kerjasama Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Asuransi PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") ini dibuat dan ditanda tangani secara sirkuler oleh dan antara:

- 1) **PT** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di beralamat di Jalan Nomor Kota/Kabupaten – Provinsi anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dimuat dalam Akta Nomor Tanggal dibuat oleh dan dihadapan S.H, MKn, Notaris, berkedudukan di telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana suratnya Nomor: AHU-AH Tanggal dalam hal ini diwakili oleh dalam kedudukannya selaku **Direktur**, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2) **PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Jakarta Pusat, beralamat di Citra Towers–Tower Utara Lantai 9 Jalan Benyamin Suaeb Kav. A6 Kemayoran–Jakarta Pusat 10630, anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dimuat dalam Akta No. 107 tanggal 30 Juni 2021 dibuat oleh dan dihadapan Ny. Suwarni Sukiman, SH, Notaris berkedudukan di Jakarta, telah diterima dan dicatat oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0428330 tanggal 14 Juli 2021, dalam hal ini diwakili oleh **Subagyo, SE As, AAIK, AMRP**, dalam kedudukannya selaku **Direktur Teknik** dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Perjanjian berarti seluruh dokumen ini, termasuk lampiran (-lampiran) nya sebagaimana aslinya dan/atau telah ditambah, diralat, atau diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** , sesuai dengan ketentuan yang ada dan disepakati bersama.
Dalam Perjanjian, penunjukan pada suatu lampiran dari dokumen ini dan penunjukkan pada suatu pasal harus dibaca dan diartikan sebagai lampiran atau pasal dari Perjanjian.
Jika terdapat pertentangan salah satu (lebih) antara ketentuan dalam Perjanjian dengan ketentuan dari lampiran (- lampiran) maka yang berlaku adalah ketentuan Perjanjian ini.
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah adalah suatu Badan Hukum yang bergerak dalam bidang jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat, termasuk bagi Peserta Asuransi, yang memiliki izin sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang didukung oleh fasilitas-fasilitas Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Manajemen, yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai Rumah Sakit, dalam hal ini dikenal secara umum dengan nama "**RUMAH SAKIT.....**"
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa Asuransi Kerugian/Uum termasuk tetapi tidak terbatas pada Asuransi Kesehatan, memiliki izin usaha/operasional yang sah dari Otoritas Jasa Keuangan/OJK.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat dengan memelihara itikad baik dan sesuai standar bisnis yang semestinya untuk saling bekerja-sama, dimana **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mendapatkan pelayanan medis dan/atau perawatan kesehatan dari Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** atas Peserta Asuransi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** bersedia dan sanggup untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta Asuransi **PIHAK KEDUA**.
- e. Bahwa **PARA PIHAK** setuju dan menjamin untuk menetapkan syarat dan ketentuan guna melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian dengan penanganan dan perhatian serta melaksanakan berbagai tindakan yang diperlukan dengan sewajarnya, dilaksanakan semestinya sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** masing-masing dengan dilandasi itikad baik bertindak dalam jabatannya telah saling sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI**

PARA PIHAK dalam Perjanjian ini sepakat, bahwa definisi-definisi yang diuraikan mempunyai arti sebagaimana dimaksud di bawah ini:

- 1) **PENGELOLA ADMINISTRASI** berarti Perusahaan penyedia tata kelola/administrasi Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, yang saat Perjanjian ini ditandatangani adalah PT Administrasi Medika (AdMedika) dan PT Medilink Digital Medika (Medilink) dan/atau Pihak lain yang dari waktu ke waktu ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PASIENT** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi dan/atau tindakan masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Dokter atau Dokter Gigi **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PESERTA** adalah Pasien yang merupakan karyawan/karyawati dan/atau anggota keluarganya yang mana telah didaftarkan oleh Pemegang Polis (Perusahaan) kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Peserta Asuransi Kesehatan **PIHAK KEDUA**.
- 4) **PELAYANAN KESEHATAN** adalah semua jasa kesehatan, termasuk pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pengobatan, pencegahan, peningkatan, dan pemulihan pasien yang bertujuan untuk menyembuhkan Peserta/Pasien dari keluhan, kondisi atau penyakit yang diderita oleh Peserta melalui rawat jalan dan/atau rawat inap dan/atau Medical Check Up/MCU, Unit Gawat Darurat/UGD. Pelayanan Kesehatan ini meliputi penggunaan peralatan kedokteran, obat-obatan, penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium, evakuasi, dan lain-lain yang diperlukan guna penyembuhan dan/atau memperoleh kesimpulan kesehatan/diagnosa, yang dilakukan pada dan/atau oleh institusi yang telah mendapat izin dan dibawah pengawasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 5) **PENYAKIT atau CEDERA** adalah kondisi fisik seseorang yang ditandai dengan penyimpangan patologi dari keadaan normal yang sehat.
- 6) **RAWAT JALAN** adalah pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan Peserta/Pasien dari kondisi, keluhan, atau penyakit yang diderita yang dilakukan oleh Dokter Umum atau Dokter Spesialis yang memiliki izin praktek yang masih berlaku, yang tidak memerlukan rawat inap. Termasuk dalam pelayanan Rawat Jalan adalah:
 - a. Pemeriksaan oleh Dokter Gigi/Umum/Spesialis/Subspesialis;
 - b. Pemberian obat;
 - c. Pemeriksaan penunjang;
 - d. Pemberian imunisasi dasar;
 - e. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - f. Bedah kecil;
 - g. Rehabilitasi medis atau fisioterapi;
 - h. IGD kurang dari 6 (enam) jam.

Kategori pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dapat dilakukan secara berjenjang dengan tahap:

- i. **RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (RJTP)** adalah semua pelayanan kesehatan rawat jalan primer yang dilaksanakan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi Umum.
 - ii. **RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT (RJTL)** adalah semua pelayanan kesehatan rawat jalan rujukan dari RJTP yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis.
- 7) **RAWAT INAP** adalah pemeriksaan, tindakan, dan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan Peserta/Pasien dari kondisi, keluhan, atau penyakit yang diderita dan memerlukan tinggal untuk dirawat sekurang-kurangnya selama 6 (enam) jam berturut-turut.

Termasuk dalam komponen biaya Rawat Inap adalah:

- a. Kamar perawatan, seperti; Ruang Isolasi, Ruang HCU, Ruang ICU, Ruang PICU, Ruang NICU, Semi ICU, Perinatologi;
- b. Biaya/jasa Kunjungan Dokter; Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Bedah;
- c. Obat-obatan;
- d. Pemeriksaan penunjang; Ultrasonography (USG), CT Scan, MRI, TORCH, Endoskopi/Gastroskopi/Kolonoskopi, dan lain sebagainya sesuai indikasi medis;
- e. Tindakan termasuk biaya bedah atau *One Day Care*;
- f. Biaya Administrasi;
- g. Biaya Ambulance;
- h. Biaya sewa kamar bedah/ruang operasi.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- 8) **RAWAT JALAN DOKTER GIGI** adalah pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan Peserta/Pasien dari kondisi, keluhan atau penyakit yang diderita dan dilakukan oleh Dokter Gigi yang memiliki izin praktek yang masih berlaku.

Termasuk dalam pelayanan Rawat Jalan Dokter Gigi adalah:

- Konsultasi dan pemeriksaan oleh Dokter Gigi;
 - Pembersihan karang gigi;
 - Penambalan gigi dengan amalgam atau komposit;
 - Pencabutan gigi termasuk geraham bungsu dengan pembiusan local dan tanpa rawat inap;
 - Pelayanan endodontik atau preparasi saluran akar gigi tetapi tidak termasuk perawatan tumor atau kanker;
 - Pengobatan abses gigi;
 - Obat-obatan yang diresepkan oleh Dokter Gigi, tetapi tidak termasuk perawatan Tumor dan Kanker Gigi.
- 9) **PERSALINAN** adalah pelayanan medis yang ditujukan untuk perawatan kehamilan, persalinan dan masa nifas. Kecuali dinyatakan lain maka keguguran oleh sebab alasan medis dapat digolongkan ke dalam persalinan, termasuk tindakan terminasi kehamilan beserta pemeriksaan yang menyertainya yang diperlukan oleh dan diberikan kepada Peserta/Pasien Asuransi sesuai dengan standar kesehatan dan bukan semata-mata untuk memenuhi kehendak pribadi Peserta/Pasien Asuransi atau Dokter yang merawatnya.
- Dengan metode persalinan:
- Melahirkan tanpa operasi (normal, vacuum, forceps);
 - Melahirkan dengan operasi (section caesaria);
 - Keguguran kandungan;
 - Pemeriksaan selama kehamilan dan setelah melahirkan
- 10) **PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK** adalah pemeriksaan penunjang dalam rangka penegakan diagnosa atau untuk melakukan pemantauan kondisi kesehatan Peserta/Pasien.
- 11) **OPERASI** adalah tindakan medis spesialis dengan menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan atau/tanpa tenaga anastesi pada ruangan tertentu (*Operation Theatre*).
- 12) **FISIOTERAPI** adalah terapi dengan menggunakan cara fisik seperti memanaskan, mendinginkan, merendam, mengurut, penguapan, penyinaran, dll.
- 13) **TERAPI LASER** adalah suatu metode pengobatan dengan menggunakan teknologi laser sebagai alat untuk menghancurkan atau menghilangkan gangguan/kelainan medis oleh seorang tenaga spesialis dapat dilaksanakan dengan atau tanpa Rawat Inap.
- 14) **TENAGA MEDIS** adalah seseorang yang telah melaksanakan pendidikan formal dibidang kesehatan dan diakui oleh Kementerian Kesehatan untuk mempraktekkan bidang ilmunya kepada masyarakat, misalnya: Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Bidan, Perawat (*Nurse*), dan Physiotherapist.
- 15) **ONE DAY SURGERY** adalah tindakan spesialis yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan atau tanpa anastesi dimana Peserta/Pasien dapat langsung pulang, tanpa harus melaksanakan Rawat Inap (merupakan paket tindakan yang terdiri dari tindakan Dokter, anastesi dan obat, serta sewa kamar).
- 16) **ALAT BANTU DENGAN PROTESA** adalah peralatan medis (*Medical Equipment*) yang karena keterbatasan Peserta/Pasien dibutuhkan untuk memperbaiki fungsi anggota gerak maupun fungsi penglihatan atau pendengaran. Alat-alat tersebut di atas adalah tidak terbatas kepada kursi roda, tongkat, collar splint, pen, hearing aid, pioкса anggota gerak atau mata dengan harga yang telah disepakati bersama.
- 17) **OBAT** adalah senyawa kimia yang berdasarkan farmakologi ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan terdaftar sebagai obat pada ISO, MIMS, DOEN. Tidak semua obat dapat ditanggung (obat yang dikecualikan) oleh **PIHAK KEDUA** antara lain:
- Obat gangguan kejiwaan;
 - Obat disfungsi seksual;
 - Obat yang nyata-nyata ditujukan untuk kecantikan dan penyesuaian berat badan;
 - Obat untuk kesuburan.
- 18) **VITAMIN** adalah vitamin murni yang bukan dalam bentuk kombinasi dengan suplemen atau obat lain, contoh vitamin: vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, dan multi vitamin.
- 19) **MULTIVITAMIN** adalah suplemen yang mengandung kumpulan vitamin yang dibutuhkan untuk membantu mengobati atau mencegah defisiensi vitamin akibat diet yang buruk, penyakit tertentu atau ketika mengalami kehamilan. Terdapat 13 nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- 20) **SUPLEMEN** adalah nutrisi yang digunakan untuk melengkapi makanan, terdiri dari satu atau lebih bahan yang dapat berupa vitamin, mineral, herbal atau tumbuhan, asam amino, serta zat-zat yang digunakan untuk meningkatkan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
- 21) **IMUNISASI** adalah tindakan medis yang bertujuan untuk memberikan kekebalan baik kekebalan sementara maupun kekebalan menetap dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (*Vaccine Preventable Disease*). Termasuk dalam imunisasi dasar ini adalah:
- a. BCG;
 - b. DPT tidak termasuk pemberian Infantrik atau yang sejenis;
 - c. POLIO;
 - d. Campak;
 - e. Hepatitis B;
- Pemberian imunisasi dasar hanya untuk bayi dan balita.
Tindakan pemberian kekebalan lanjutan (*Booster*) tidak ditanggung atau dikecualikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 22) **KELUARGA BERENCANA** adalah tindakan medis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konsepsi. Termasuk dalam pelayanan keluarga berencana adalah:
- a. Pil Keluarga Berencana;
 - b. Suntikan;
 - c. *Intra Uterine Device (IUD)*;
 - d. Implant/Susuk.
- 23) **SURAT JAMINAN** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** yang berisi pernyataan bahwa biaya pelayanan kesehatan termasuk ketentuan (-ketentuan) dan batasan (-batasan) lain yang dinyatakan dengan jelas terhadap orang yang namanya disebutkan didalamnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- 24) **FORMULIR KLAIM** adalah formulir yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk dilengkapi oleh **PIHAK PERTAMA** dan merupakan bukti transaksi setelah ditandatangani oleh Peserta yang Namanya disebut pada Kartu Peserta atau pada Surat Jaminan.
Formulir Klaim ini akan dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA** disertai/dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
- a. Kuitansi asli dengan meterai yang cukup;
 - b. Rincian pembayaran;
 - c. Resume Medis;
 - d. Copy resep dan permintaan penunjang serta hasilnya jika diperlukan.
- 25) **RESUME MEDIS** adalah ringkasan riwayat penyakit dan tindakan dan/atau pengobatan yang diberikan kepada Pasien/Peserta selama dirawat.
Resume Medis diisi dengan benar dan wajib ditandatangani oleh Dokter yang merawat sesuai dengan apa yang dilihat, diperiksa, tindakan yang dilakukan pengobatan yang diberikan dan tidak ada keterangan lain yang disembunyikan untuk menghalangi **PIHAK KEDUA** dari hak untuk tidak membayar. Resume Medis wajib ditandatangani oleh Dokter yang merawat.
- 26) **SURAT PERNYATAAN RUMAH SAKIT** adalah surat/formulir yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berisikan keterangan dari **PIHAK PERTAMA** bahwa hak kelas kamar perawatan Peserta/Pasien **PIHAK KEDUA** tidak tersedia karena penuh atau karena tidak tersedia tarif kamar sesuai hak Peserta/Pasien. Peserta/Pasien menempati kamar yang lebih tinggi atas permintaannya sendiri, surat/formulir tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh petugas administrasi rawat inap **PIHAK PERTAMA** dan Peserta/Pasien, sebagai dasar penerbitan Surat Jaminan.
- 27) **SURAT PERNYATAAN PESERTA** adalah surat yang dipersiapkan oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap bagian Administrasi **PIHAK PERTAMA** untuk ditandatangani oleh Peserta/Pasien **PIHAK KEDUA** yang menjalani perawatan di Rumah Sakit/Klinik **PIHAK PERTAMA**. Surat ini adalah salah satu dokumen pengajuan tagihan pengobatan yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 28) **KARTU PESERTA** adalah kartu yang menunjukkan bahwa orang yang namanya tertulis pada kartu adalah Peserta asuransi yang menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**. Kartu Peserta merupakan bukti bahwa pemegangnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan pada jaringan Klinik atau Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menunjukkan Kartu Peserta dan sesuai dengan haknya serta dilengkapi dengan surat jaminan (khusus Rawat Inap) maka Peserta dibebaskan dari tagihan biaya pelayanan kesehatan.

Pada Kartu Peserta sekurang-kurangnya tercantum:

- a. Nama Peserta;
- b. Nomor Peserta;
- c. Tanggal mulai berlaku;
- d. Tanggal berakhirnya kepesertaan;
- e. Pelayanan kesehatan termasuk kelas/hak kamar yang menjadi hak Peserta/Pasien.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- 29) **RUJUKAN** adalah tindakan mengirimkan Peserta/Pasien ke Dokter lain atau instalasi lain atau ke Rumah Sakit lain yang bertujuan untuk menegakkan diagnosa atau menyembuhkan penyakit Pasien. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** merujuk ke institusi lain maka sebelumnya wajib mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- 30) **LEPAS RAWAT INAP** adalah waktu diterbitkannya tagihan (*bill*) ke Peserta/Pasien oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 31) **PENGECUALIAN** adalah kondisi, penyakit, pemeriksaan, tindakan, atau pengobatan yang dikecualikan dari Perjanjian, dimana biaya yang timbul dan/atau ditimbulkan bukan menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**. Daftar pengecualian tertera pada lampiran Perjanjian dan dijadikan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan serta menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 32) **GAWAT DARURAT** adalah kondisi dimana Peserta/Pasien harus mendapatkan pertolongan medis segera dan tidak dapat ditunda, sebab dapat mengakibatkan kematian atau cacat tetap.
- 33) **KEBUTUHAN MEDIS** adalah pemeriksaan tindakan dan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit yang didasarkan kepada keluhan Peserta/Pasien dan sesuai dengan standar pelayanan medis **PIHAK PERTAMA** dan bukan merupakan sesuatu yang masih dalam tahap uji klinis atau percobaan.
- 34) **PERLU SECARA MEDIS** adalah semua pelayanan kesehatan yang berkaitan secara langsung dengan keadaan medis Peserta/Pasien, yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan Peserta/Pasien dan sejalan dengan diagnosis dan keadaan klinis Peserta/Pasien, serta sesuai dengan Standar Pelayanan Medis Ikatan Dokter Indonesia (SPM IDI) dan bukan semata-mata untuk memenuhi kehendak Peserta/Pasien atau Dokter yang merawatnya. Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan untuk pengobatan yang perlu secara medis, efisien dan tidak bersifat percobaan atau eksperimen.
- 35) **TARIF** adalah daftar harga pelayanan kesehatan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA** dan merupakan dasar bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal terjadi perubahan tarif, **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berlaku.
- 36) **BIAYA NON MEDIS** adalah biaya-biaya yang tidak diperlukan atau tidak dapat dibebankan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** karena tidak sesuai dan/atau melampaui tingkat biaya atas manfaat yang dijamin, dan/atau biaya yang ditimbulkan oleh **PIHAK PERTAMA**/Dokter dalam keadaan serupa di wilayah dimana biaya tersebut bukan untuk penyediaan jasa medis atau perawatan.
- 37) **PLAN PESERTA** adalah hak klas kamar rawat inap Peserta/Pasien sebagaimana tercantum dalam Kartu Peserta Asuransi yang menginformasikan tentang batas maximum pertanggungan untuk biaya kamar perawatan Rumah Sakit per hari.
- 38) **SELISIH BIAYA PENGOBATAN/PERAWATAN RUMAH SAKIT/EKSES/EXCESS** adalah seluruh kelebihan biaya yang menjadi beban/tanggungan Peserta/Pasien dikarenakan adanya biaya perawatan melebihi batas/limit maximum manfaat yang dijamin oleh **PIHAK KEDUA**. Selisih Biaya dimaksud wajib langsung diselesaikan/ditagihkan kepada **PESERTA/PASIE**n langsung sebelum meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**, kecuali atas persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK KEDUA**, selisih biaya dimaksud dapat ditanggung terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA** untuk kemudian tagihan eksekusi tersebut ditagihkan kepada Peserta/Pasien melalui **PIHAK PERTAMA**.
- 39) **KAMAR PERAWATAN RUMAH SAKIT PENUH** adalah kondisi ruangan atau kamar yang saat itu tidak tersedia atau sedang penuh.
- 40) **KENAIKAN KELAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI (PASIE**n) adalah permintaan Peserta/Pasien untuk menempati kamar diluar limit atau plafon manfaat yang ada. Jika atas permintaan Peserta/Pasien dimana yang bersangkutan memilih dirawat dikelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya yang timbul akibat perbedaan kelas tersebut wajib ditagihkan langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta/Pasien **PIHAK KEDUA**.
- 41) **HOSPITAL MONITORING** adalah aktifitas pemantauan tentang kondisi umum Peserta/Pasien selama Rawat Inap untuk mendapatkan gambaran yang terperinci tentang:
- a.Diagnosa penyakit
 - b.Lama perawatan
 - c.Biaya perawatan
 - d.Tindakan atau pemeriksaan medis yang diperlukan

Monitoring akan dilakukan atas kesehatan Peserta/Pasien kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Untuk mengetahui kondisi umum kesehatan Peserta/Pasien, **PIHAK KEDUA** melalui permintaan tertulis berhak mendapatkan informasi dari Perawat **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- ii. Untuk mengetahui pengobatan serta kondisi secara keseluruhan atas Peserta/Pasien, **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi dari Dokter penanggung jawab pelayanan yang merawat Peserta/Pasien di **PIHAK PERTAMA**.
- 42) **TANGGUNGAN SENDIRI** adalah sejumlah biaya yang merupakan beban/tanggung jawab Peserta/Pasien untuk pembayaran pengobatan/perawatan setiap Penyakit atau Cedera yang besarnya diluar/melebihi manfaat/jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 43) **HARGA NETTO APOTIK** atau “HNA” adalah harga dasar obat yang ditetapkan oleh Distributor dan menjadi acuan bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menentukan Harga Jual Apotik atas obat-obatan yang digunakan Peserta/Pasien.
- 44) **ADMINISTRASI KEPESEERTAAN** adalah proses validasi/pemeriksaan keabsahan Kartu Peserta dan mencocokkannya dengan bukti identitas diri Peserta/Pasien yang sah dan masih berlaku (KTP/SIM) serta menyesuaikan dengan hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan oleh Peserta/Pasien.
- 45) **ADMINISTRASI JAMINAN** adalah proses permintaan dan/atau penerbitan Surat Jaminan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu memberikan informasi lisan/tertulis tentang keterangan medis sesuai dengan penyakit atau cedera yang diderita Peserta/Pasien.
- 46) **MANAJEMEN UTILISASI** adalah suatu mekanisme pengendalian biaya dan Pelayanan Kesehatan agar Peserta/Pasien menerima Pelayanan Kesehatan atau perawatan yang *adequat*/memadai (tidak berlebihan dan tidak kurang) sehingga efisien dan efektif. Manajemen utilisasi ini meliputi: sertifikasi di muka (*pre-certification*), test di muka (*pre-admission test*), persetujuan di muka (*pre-authorization*), manajemen kasus, tinjauan bersama (*concurrent review*), perencanaan Peserta/Pasien keluar rumah sakit dan tinjauan utilisasi.
- SERTIFIKASI DIMUKA** adalah program manajemen utilisasi yang mengharuskan Peserta atau **PIHAK PERTAMA** memberitahukan **PIHAK KEDUA** sebelum Peserta/Pasien dirawat atau menjalani operasi.
 - PERSETUJUAN DIMUKA** adalah persetujuan sebelumnya untuk perawatan/rujukan ke spesialisasi atau pelayanan yang bukan gawat darurat.
 - TEST DIMUKA** adalah pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik lainnya yang dilakukan (misalnya sebagai persiapan operasi) sebelum Peserta/Pasien masuk ke Rumah Sakit bila hal tersebut memungkinkan.
 - MANAJEMEN KASUS** adalah pengelolaan kasus secara bersama antara **PIHAK KEDUA** sebagai penjamin dan Dokter penanggung jawab pelayanan, dalam rangka memberikan pelayanan atau perawatan yang efisien dan efektif. Kegiatan ini dilakukan untuk kasus-kasus yang bila hal ini tidak dilakukan akan menyebabkan perawatan yang lama dan mahal.
 - TINJAUAN BERSAMA** adalah suatu metode peninjauan utilisasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di Rumah Sakit tempat Peserta/Pasien dirawat.
 - PERENCANAAN PASIEN KELUAR RUMAH SAKIT** adalah suatu rencana bagi Peserta/Pasien yang akan keluar dari Rumah Sakit. Rencana ini berisi perawatan, latihan, makanan, dan tindakan lainnya yang perlu diberikan kepada Peserta/Pasien, kapan ia harus kontrol ke Dokternya, dan lain-lain.
 - TINJAUAN UTILISASI** adalah penilaian pemanfaatan fasilitas kesehatan/rumah sakit oleh Peserta/Pasien. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan apakah pemanfaatan itu wajar atau tidak wajar
- 47) **HARI KERJA PIHAK KEDUA** adalah seluruh hari dalam 1 (satu) minggu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana bank beroperasi, selain hari Sabtu, Minggu, dan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
- 48) **HARI KALENDER** adalah seluruh hari dalam 1 (satu) minggu.

PASAL 2

LANDASAN HUKUM PERJANJIAN PELAYANAN

Yang menjadi landasan hukum perjanjian pelayanan kesehatan ini adalah:

- 1) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7 tahun 2025 tentang Asuransi Kesehatan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

PASAL 3

RUANG LINGKUP PELAYANAN

- 1) Ruang lingkup pelayanan dalam Perjanjian adalah **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan pelayanan medis/perawatan kesehatan di Rumah Sakit, sesuai dengan kemampuan serta sarana prasarana dan sarana

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

fasilitas-fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**, kepada orang yang menjadi Peserta dari **PIHAK KEDUA** dengan menyerahkan bukti berupa Kartu Peserta dari **PIHAK KEDUA (PESERTA)**.

Adapun lingkup pelayanan medis/perawatan kesehatan tersebut mencakup namun tidak terbatas pada:

- a. Layanan Rawat Jalan Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis atau Dokter Gigi;
- b. Layanan Rawat Inap, termasuk Instalasi Gawat Darurat, Ruang Isolasi, *High Care Unit (HCU)*, *Intensive Care Unit (ICU)*, *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* serta *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*, *semi-ICU* dan Perinatologi;
- c. Layanan darurat termasuk ambulans;
- d. Layanan perawatan satu hari (*One Day Care*);
- e. Layanan tambahan, termasuk radiologi, laboratorium, farmasi, kemoterapi dan dialisis, ESWL;
- f. Layanan Persalinan;
- g. Layanan Imunisasi;
- h. Layanan Keluarga Berencana.

Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, Peserta/Pasien harus memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali ditentukan lain oleh **PIHAK KEDUA**.

- 2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** oleh karena keterbatasan fasilitas yang ada, dimana Peserta/Pasien dari **PIHAK KEDUA** memerlukan tindakan dan atau perawatan lebih lanjut, maka **PIHAK PERTAMA** atas persetujuan **PIHAK KEDUA** dapat merujuk Peserta/Pasien dari **PIHAK KEDUA** ke Rumah Sakit lain yang memiliki fasilitas yang dimaksud/dibutuhkan.

PASAL 4 PROSEDUR PELAYANAN

- 1) Dalam memberikan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta, **PIHAK KEDUA** menetapkan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang wajib dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan ini, yaitu Peserta/Pasien, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

- 2) Pada prinsipnya, prosedur pelayanan kesehatan ditentukan sebagai berikut:

a. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

- i. Kepada setiap Peserta/Pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas **PIHAK PERTAMA**, maka Petugas pendaftaran rawat jalan **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan verifikasi/memeriksa dan validasi/meneliti keabsahan serta Administrasi Kepesertaan termasuk masa berlakunya serta menyesuaikan dengan hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan oleh Peserta/Pasien.
- ii. Dalam hal tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta dan/atau yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam rangka romawi (i) di atas maka atas Peserta/Pasien dimaksud wajib diberlakukan sebagai **PASIENT UMUM**, dan karenanya bukan menjadi dan/atau diluar tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- iii. Apabila telah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis, maka **PIHAK PERTAMA** membebaskan Peserta/Pasien dari kewajiban pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan, karena seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab dan karenanya wajib dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.
- iv. Segala bentuk pelayanan yang tidak menjadi tanggungan atau yang dikecualikan berdasarkan Polis **PIHAK KEDUA**, oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** wajib menagih secara langsung ke Peserta/Pasien sebelum meninggalkan Rumah Sakit kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- v. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian atas hal ini maka seluruh akibat yang mungkin timbul atau ditimbulkan bukan merupakan tanggung jawab hukum **PIHAK KEDUA**.
- vi. **PIHAK PERTAMA** wajib memperlihatkan dan menyerahkan seluruh rincian biaya kepada **PIHAK KEDUA** atas segala hal yang terjadi kepada Peserta/Pasien akibat pelayanan yang digunakan Peserta/Pasien.
- vii. **PIHAK PERTAMA** wajib meminta Peserta/Pasien untuk menandatangani kuitansi tagihan sebagai tanda persetujuannya atas jumlah biaya yang ditagihkan.

b. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Inap

- i. Kepada setiap Peserta/Pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**, maka Petugas pendaftaran rawat inap **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan verifikasi/memeriksa dan validasi/meneliti keabsahan serta Administrasi Kepesertaan termasuk masa berlakunya serta menyesuaikan dengan hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan oleh Peserta/Pasien.
- ii. Peserta/Pasien/Tertanggung yang hendak mendapatkan pelayanan Rawat Inap wajib berdasarkan Surat Rujukan Dokter yang merawat.
- iii. Pemberian pelayanan Rawat Inap wajib berdasarkan surat rujukan Dokter yang merawat, data serta identitasnya tercantum dalam Surat Jaminan, bahwa Peserta/Pasien berhak untuk mendapatkan fasilitas Rawat Inap.
- iv. Dalam hal tidak dapat menunjukan Kartu Peserta dan/atau yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, maka atas Peserta/Pasien dimaksud akan diberlakukan sebagai **PASIENT UMUM**, dan karenanya bukan menjadi dan/atau diluar tanggung jawab hukum **PIHAK KEDUA**.
- v. **PIHAK PERTAMA** wajib meminta surat jaminan dan hak pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan Peserta kepada **PIHAK KEDUA**, dan wajib menyampaikan Laporan Medis Awal (LMA) kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- vi. **PIHAK KEDUA** menyampaikan Surat Jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 2X24 (dua kali dua puluh empat jam) setelah Laporan Medis Awal (LMA) diterima dari **PIHAK PERTAMA** yang akan dikirimkan melalui faximile atau email atau What's Application (WA) atau sarana komunikasi tercepat lainnya. Jika dalam jangka waktu 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam) tersebut jatuh pada hari libur resmi (hari Minggu) dan/atau hari Libur Nasional maka jangka waktu dimaksud adalah diperpanjang 24 jam (dua puluh empat jam) hari kerja pertama berikutnya.
- vii. **PIHAK PERTAMA** wajib mendapat persetujuan tertulis dalam bentuk Surat Jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk hal-hal sebagai berikut:
- Rawat Inap;
 - Kenaikan kelas kamar perawatan;
 - Pemeriksaan penunjang yang dapat digolongkan sebagai pemeriksaan penunjang bukan rutin untuk Rawat Inap seperti:
 - Ultrasonography (USG);
 - CT Scan;
 - MRI;
 - TORCH;
 - Endoskopi/Gastroskopi/Kolonoskopi.
 - **PIHAK PERTAMA** wajib menghubungi atau melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila Peserta/Pasien akan melakukan tindakan atau pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi, dll) Jika Peserta/Pasien berdasarkan indikasi medisnya memerlukan pemeriksaan tersebut (indikasi medis merupakan kewenangan penuh Dokter Pemeriksa) sedangkan untuk pemeriksaan penunjang dengan biaya tinggi atau lebih dari Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) per/setiap pemeriksaan dan tindakan operasi akan dikonfirmasi terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**, kecuali apabila Peserta/Pasien dalam keadaan emergency/CITO.
 - **PIHAK PERTAMA** wajib menghubungi atau melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat obat-obatan yang biayanya mencapai dan/atau lebih dari Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jenis obat atau per item obat.
- viii. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menjamin tindakan bedah elektif yang dilakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Besar Nasional kecuali bersifat mendesak (CITO) dan sebelumnya telah mendapat persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**.
- ix. **PIHAK PERTAMA** wajib menempatkan Peserta/Pasien yang memerlukan perawatan atau rawat inap sesuai Plan/Benefit Peserta/Pasien.
- x. Apabila oleh sebab-sebab lain sehingga biaya Pelayanan Kesehatan Peserta/Pasien yang bersangkutan menjadi lebih besar atau diluar Plan/Benefit yang dimiliki, maka kelebihan tersebut tidak termasuk dan/atau dikecualikan dari beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Karenanya Peserta/Pasien wajib menyelesaikan kelebihan biaya tersebut sebelum meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** membebaskan dan melepaskan **PIHAK KEDUA** dari tanggung jawab terhadap tagihan tersebut, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK KEDUA**.
- xi. Kenaikan kelas kamar atas permintaan Peserta/Pasien menjadi tanggung jawab Peserta/Pasien, dan **PIHAK PERTAMA** wajib mendapatkan surat persetujuan membayar kelebihan biaya dari Peserta/Pasien dan harus diselesaikan pada saat Pasien/Peserta keluar/selesai menjalani tahapan perawatan dari Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** membebaskan dan melepaskan **PIHAK KEDUA** dari tanggung jawab hukum atas tagihan tersebut, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK KEDUA**.
- xii. **PIHAK KEDUA** dapat mencabut/menarik kembali Surat Jaminan karena sebab-sebab sebagai berikut:
- a. Kondisi Peserta/Pasien tidak sesuai indikasi medis dan rekomendasi Dokter.
 - b. Polis tidak aktif (lapse).
 - c. Kondisi medis Peserta/Pasien sebagaimana dimaksud tidak dijamin dalam benefit polis
 - d. Kondisi medis Peserta/Pasien sebagaimana dimaksud termasuk dalam pengecualian Polis (mengacu pada Lampiran III dalam Perjanjian ini).
 - e. Peserta/Pasien berada dalam tahap masa tunggu. Polis **PIHAK KEDUA** tidak menjamin ketidakmampuan secara fisik yang telah ada sebelumnya dan Penyakit Khusus (*Pre-Existing Medical Condition*) selama 12 bulan (dua belas bulan) pertama sejak tanggal efektif Peserta/Pasien.
- xiii. Bila Peserta/Pasien tidak dapat menunjukkan bukti kepesertaan yang sah dan masih berlaku (dengan alasan hilang/lupa/kadaluarsa dan lain-lainnya) maka kepada Peserta/Pasien dimaksud diberlakukan sebagai **PASIENT UMUM**, kecuali ada Surat Jaminan perawatan atau konfirmasi dari **PIHAK KEDUA**.
- xiv. Berdasarkan Perjanjian **PIHAK KEDUA**, dan selama telah memenuhi dan/atau sesuai kualifikasi kepesertaan yang ditentukan, Peserta/Pasien dibebaskan dari/tidak dikenakan pembayaran *Down Payment (DP)*/Uang Muka dan Biaya Jasa Pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan dari program Pelayanan Kesehatan yang diikuti oleh Peserta/Pasien tersebut.
- xv. Setiap Peserta dibedakan dalam beberapa plan atau kelas sesuai dengan benefit/plan atas program pelayanan kesehatan yang diikuti oleh Peserta/Pasien tersebut yang ditetapkan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Prosedur Pelayanan Kesehatan Keadaan Gawat Darurat
- i. Dalam hal Peserta/Pasien mengalami keadaan gawat darurat (sakit mendadak atau mengalami kecelakaan) pada hari libur resmi (hari Minggu dan/atau hari Libur Nasional) dan harus segera mendapatkan pertolongan secara medis (Rawat Jalan), maka **PIHAK PERTAMA** tetap memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan terhadap Peserta/Pasien tersebut dengan ketentuan Peserta tetap wajib menunjukkan kartu peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- ii. Untuk kondisi gawat darurat yang memerlukan Rawat Inap, Peserta/Pasien diberi keleluasaan untuk menunjukkan kartu Peserta selambat-lambatnya 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam) atau dapat menghubungi **PIHAK KEDUA** untuk mendapat persetujuan.
- iii. Suatu pelayanan kesehatan keadaan gawat darurat yang dilakukan di ruang gawat darurat atau poliklinik rawat jalan dimana pelayanan kesehatan itu tidak dilanjutkan dengan Rawat Inap maka pelayanan kesehatan tersebut dikategorikan Rawat Jalan. Tetapi jika pelayanan kesehatan pada keadaan gawat darurat yang dilakukan di ruang gawat darurat atau poliklinik rawat jalan tersebut dilanjutkan dengan rawat inap, maka semua biaya yang terjadi akan dimasukkan dalam kategori biaya rawat inap.

- 3) Pelaporan dan Tindak Lanjut
- a. Paling sedikit, bila perlu sekali dalam setiap kuartal **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan rapat rutin atau evaluasi untuk membahas pelaksanaan Perjanjian.
 - b. Dalam rapat rutin yang diadakan tersebut **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** membicarakan program-program, kendala dan solusinya.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
- a. Menerima Surat Jaminan terhadap Peserta/Pasien yang menerima layanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan metode yang disepakati dalam Perjanjian.
 - b. Menerima pembayaran tagihan biaya-biaya layanan kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.
 - c. Berhak menerima informasi dan pemutakhirannya/pengkinian informasi dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas kepada informasi program asuransi, update kepesertaan, penggunaan jasa **PIHAK KETIGA** (*Pengelola Administrasi/Third Party Administrator/TPA*), perubahan alamat, perubahan status badan hukum **PIHAK KEDUA** dan sebagainya yang mendukung pelaksanaan Perjanjian.
- 2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. Meminta konfirmasi dari **PIHAK KEDUA** sehubungan Pelayanan Kesehatan atas diri Peserta/Pasien untuk dirawat inap di Rumah Sakit, serta mendapatkan Surat Jaminan Rawat Inap dari **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk konfirmasi (jawaban).
 - b. Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta/Pasien sesuai dengan Plan/Benefit Peserta.
 - c. Menerbitkan buku tarif dan menyerahkannya kepada **PIHAK KEDUA** sebagai acuan dalam menentukan jumlah klaim yang ditagihkan.
 - d. Tidak membedakan pelayanan kepada Peserta/Pasien **PIHAK KEDUA** dalam pemberian Pelayanan Kesehatan, sama seperti **PASIENT UMUM**.
 - e. Mengikuti SOP Pelayanan Kesehatan yang dibuat **PIHAK KEDUA** dan disepakati **PARA PIHAK**.
 - f. Menolak Peserta/Pasien dalam hal-hal sebagai berikut :
 - i. Peserta/Pasien tidak dapat menunjukkan bukti kepesertaan yang sah berupa Kartu Peserta yang berlaku dan Bukti Identitas Diri lain, kecuali telah mendapatkan konfirmasi sebelumnya dari **PIHAK KEDUA** mengenai kepesertaan Peserta;
 - ii. **PIHAK PERTAMA** telah diinformasikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** bahwa Peserta/Pasien sudah dihentikan dan/atau tidak terdaftar kepesertaannya oleh Pemegang Polis (Perusahaan) dan pemberitahuan telah diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
 - iii. Peserta/Pasien meminta **PIHAK PERTAMA** untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosa medis, dan/atau informasi apapun yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - iv. Peserta/Pasien berinisiatif meminta Pelayanan Kesehatan yang tidak perlu secara medis atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti tes laboratorium dan tes diagnostik.
 - v. Peserta/Pasien meminta Pelayanan Kesehatan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis dalam/tidak sesuai dengan Kartu Peserta atau Surat Jaminan Rawat Inap
 - vi. Peserta/Pasien meminta Pelayanan Kesehatan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis dalam/tidak sesuai dengan Kartu Peserta. Karyawan dan keluarga bertanggung **PIHAK KEDUA** meminta **PIHAK PERTAMA** untuk mengubah tanggal perawatan dan/atau mengubah diagnosa, melakukan pemeriksaan lab dan/diagnostik yang tidak diperlukan secara medis dan/atau tidak berhubungan dengan diagnosa pengobatan yang dijalani, meminta pelayanan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tercantum dalam Kartu Peserta, dan melakukan pemalsuan, penipuan, dan atau rekayasa atas suatu klaim pengobatan termasuk tetapi tidak terbatas mengeluarkan kuitansi palsu, mengeluarkan lebih dari 1 (satu) kuitansi asli atas klaim yang sama, dan lain-lain. .
 - g. Memberikan rincian biaya atau keterangan medis mengenai Peserta/Pasien bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - h. Membantu pelaksanaan *Hospital Monitoring*.
 - i. Menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam kaitannya dengan *Hospital Monitoring* pada saat Peserta/Pasien akan mulai dilakukan Rawat Inap.
- 3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan jasa Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** untuk para Peserta/Pasien, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

- b. Menolak pembayaran biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang tidak Perlu Secara Medis, atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan/atau menolak pembayaran kelebihan biaya (-biaya) yang diajukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menolak perubahan tarif yang tidak dilakukan sesuai dengan Perjanjian.
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menghentikan pemberian jaminan atas fasilitas Layanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta/Pasien Asuransi dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya sebelum Peserta/Pasien lepas rawat inap/jalan dan/atau meninggalkan rumah sakit.
 - e. Melakukan telaah/Review utilisasi (Manajemen Utilisasi) bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian.
- 4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerbitkan Kartu Peserta atau Bukti Identitas Diri lain yang dipergunakan oleh setiap Peserta untuk membuktikan identitas dan berlakunya kepesertaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Membayar tagihan biaya (-biaya) Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atas diri Peserta, yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
 - c. Memberikan konfirmasi kepesertaan untuk kasus Rawat Inap atas diri Peserta dan menerbitkan Surat Jaminan Rawat Inap kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 TARIF DAN POTONGAN HARGA

- 1) Penggantian biaya Layanan Kesehatan yang diberikan/disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** mengacu pada tarif yang berlaku secara umum dari waktu ke waktu pada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** tidak akan menarik biaya apapun terhadap Peserta/Pasien selain dari yang telah disepakati dalam dan/atau berdasarkan Perjanjian.
- 3) Setiap perubahan pada tarif dan/atau buku tarif harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemberlakuan efektif tarif baru tersebut. Perubahan tarif baru dimaksud tidak berlaku surut.
- 4) Atas biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan, **PIHAK PERTAMA** bersedia/setuju dengan berdasarkan ketentuan tarif sebagaimana terlampir (*Lampiran 1*).
- 5) Atas biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan, **PIHAK PERTAMA** sepakat memberikan potongan harga/rebate sebesar **10% (sepuluh per seratus)** dari Total Tagihan kepada **PIHAK KEDUA**.

Potongan harga (*rebate*) tersebut akan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada **PIHAK KEDUA**, yang dikeluarkan jika **PIHAK KEDUA** telah membayar lunas seluruh tagihan dibulan tersebut. **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali besaran presentase potongan harga yang diberikan. **PIHAK KEDUA** mengirimkan tagihan kepada email penagihan kami. Pemberian rebate dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara transfer melalui rekening yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** yaitu:

Atas Nama : PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia
No. Rekening : 7403688888
Bank : BCA KCP Citra Tower

- 6) Apabila Layanan Kesehatan yang diberikan adalah berkenaan dengan pemberian obat kepada Peserta, maka **PARA PIHAK** setuju untuk memberlakukan ketentuan tentang Harga Jual Apotik atas harga obat yang diberikan kepada Peserta/Pasien berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu sama dengan dan/atau tidak lebih tinggi dari Harga Ecer Tertinggi (HET) mengacu pada Permenkes No. 98 Tahun 2015 Pasal 7 Butir 1.

PASAL 7 PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Atas pelayanan kesehatan yang diberikan maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan tagihan sesuai dengan dokumen (-dokumen) yang dipersyaratkan secara lengkap, sah dan benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang telah disepakati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta/Pasien selesai menerima pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA**. Apabila penagihan dilakukan melebihi batas waktu tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menunda pembayaran. Penundaan pembayaran untuk tagihan tidak lengkap tersebut tidak akan menunda tagihan pembayaran lainnya yang telah lengkap/tidak bermasalah.
- 2) **PIHAK KEDUA** membayar tagihan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak seluruh berkas tagihan dinyatakan diterima secara lengkap, sah dan benar.
- 3) **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi atas dokumen yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sejak diterimanya dokumen tagihan. Dalam periode tersebut **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat kekurangan

Commented [RP1]: Nilai diskon 10% adalah pengajuan yang kami ajukan yang dimana Kembali lagi pada kesepakatan Bersama.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

dokumen tagihan. **PIHAK KEDUA** memberi batas waktu maksimum kadaluarsa klaim dan/atau dokumen tidak lengkap kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melengkapi kelengkapan berkas klaim tersebut selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut. Apabila **PIHAK PERTAMA** sampai dengan batas waktu maksimum yang telah ditentukan belum dapat memenuhi kelengkapan berkas klaim. Dalam hal ketentuan ini tidak dipenuhi, **PIHAK KEDUA** tidak wajib membayarkan tagihan klaim tertanggung.

- 4) Penundaan pembayaran atas tagihan kadaluarsa dan/atau dokumen tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 3, tidak akan menunda tagihan (-tagihan) lain yang telah lengkap, sah dan benar/tidak bermasalah.
- 5) Dalam melakukan pembayaran maka **PARA PIHAK** selalu merujuk dan berdasarkan kepada ketentuan tarif yang disepakati.
- 6) Apabila terdapat tagihan yang belum dapat dibayarkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberi keterangan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dilengkapi dengan alasan (-alasan), berikut instruksi lebih lanjut.
- 7) Pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** wajib dilakukan melalui transfer ke rekening:

Nama Bank	:	
Cabang	:	
Nomor Rekening	:	
Atas nama	:	
- 8) Dokumen penagihan klaim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diantaranya adalah :
 - a. Formulir pelayanan medis atau bukti kunjungan yang ditandatangani oleh Peserta/Pasien;
 - b. Kuitansi asli (bermeterai cukup), rincian biaya perawatan dan rekapitulasi tagihan klaim;
 - c. Dokumen Pendukung sesuai dengan Layanan Kesehatan yang diberikan (bukti tindakan/Penunjang Diagnostik);
 - d. Surat Rujukan;
 - e. Foto copy Resep;
 - f. Resume Medis (khusus untuk Rawat Inap);
 - g. Fotokopi Kartu Peserta;
 - h. Surat Jaminan (khusus untuk Rawat Inap atau Tindakan Khusus);
 - i. Surat pengantar tagihan yang dilengkapi data rekening tujuan pembayaran tagihan.
- 9) Dalam hal karena suatu alasan yang sah dan diatur dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas karena keterlambatan pembayaran karena alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian sehingga **PIHAK PERTAMA** bermaksud melakukan penutupan layanan sementara, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan Surat Peringatan atau Surat Pemberitahuan Penutupan Layanan Sementara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif layanan penutupan akan diberlakukan.

PASAL 8 MUTU PELAYANAN

- 1) Untuk memastikan mutu pelayanan **PIHAK PERTAMA** kepada Pasien atau Peserta maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas (-fasilitas) yang dipergunakan pada klinik yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut. Dalam hal **PIHAK KEDUA** sudah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas (-fasilitas) yang dipergunakan pada Klinik yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** pada tanggal dan waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Mutu pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan, standar dan praktek ilmu kedokteran IDI dan PDGI – Kemenkes serta PPK (Panduan Praktek Klinis) yang diketahui Kolegium.
- 3) Untuk meningkatkan mutu pelayanan (*continuous improvement*), **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertemuan secara berkala dalam waktu sebagaimana ditentukan **PARA PIHAK** bilamana diperlukan.

PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Kerja Sama ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal dibubuhkannya tanda tangan terakhir dari **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31-12-202..... (tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh). Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum/amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2) Dalam hal pada saat jangka waktu Perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) Perjanjian, namun tidak ada salah satu pihak pun yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian, maka **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian secara otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

- 3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum masa berlakunya berakhir karena sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian, maka Pihak dimaksud wajib menyampaikan surat Pemberitahuan, kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektifnya pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki, kecuali apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu Pihak maka syarat dan ketentuan mengenai jangka waktu pemberitahuan tersebut menjadi tidak berlaku.
- 4) Perjanjian tetap berlaku, mengikat dan tidak merubah berlakunya, walaupun ada perubahan dan/atau penggantian atas susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, Para Pemegang Saham pada masing-masing Pihak.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Selain karena sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 9 tentang jangka waktu Perjanjian, Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal karena sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Pengakhiran oleh salah satu Pihak.
- 2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu tanpa perlu meminta persetujuan dari pihak lainnya.
- 3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.
- 4) **PARA PIHAK** dengan ini setuju untuk mengesampingkan penerapan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dan oleh karena itu untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan suatu keputusan Hakim terlebih dahulu.
- 5) Pelaksanaan pemutusan berdasarkan Perjanjian tidak mengurangi atau menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang timbul dan/atau masih ada, baik belum dilaksanakan dan masih harus diselesaikan berdasarkan Perjanjian, oleh karenanya **PARA PIHAK** masih tetap mempunyai kewajiban serta tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian.

PASAL 11 PENGUNAAN NAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** setuju bahwa setiap bahan pemasaran atau informasi tertulis yang menyebutkan **PIHAK KEDUA** harus disetujui secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** sebelum disebarluaskan.
- 2) **PIHAK KEDUA** setuju juga bahwa setiap bahan pemasaran atau informasi tertulis yang menyebutkan **PIHAK PERTAMA** harus disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum disebarluaskan.

PASAL 12 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini saling menyatakan dan saling menjamin Pihak yang satu kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) **PARA PIHAK** adalah badan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang mempunyai hak penuh dan berwenang untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian.
- 2) Perjanjian tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing Pihak, serta tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib ditaati oleh **PARA PIHAK** dalam menjalankan usaha Perseroan.
- 3) Pejabat dari **PARA PIHAK** selaku subyek hukum yang menandatangani Perjanjian telah mengambil semua tindakan yang diperlukan, haruslah dianggap mempunyai hak, kewenangan dan sah menurut Anggaran Dasar masing-masing Pihak, sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bertindak untuk dan atas nama yang diwakili atau atas nama **PARA PIHAK** dalam Perjanjian, termasuk untuk membuat dan menandatangani seluruh dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian, karenanya tidak ada alasan dari Pihak manapun yang dapat menyatakan adanya kekeliruan kewenangan dalam Perjanjian, apabila dikehendaki satu dengan yang lain, **PARA PIHAK** wajib memberikan bukti yang sah menurut hukum mengenai hal tersebut.
- 4) Jika diperlukan oleh Pihak yang satu atas Pihak yang lain, **PARA PIHAK** wajib menyampaikan, menyerahkan data-data, dokumen-dokumen pengenalan, perizinan dan/atau Anggaran Dasar dengan lengkap dan benar, termasuk seluruh perubahan dan/atau tambahan dan terhadap Anggaran Dasar, yang pada saat dimaksud tidak/belum diadakan perubahan atau tambahan lagi berupa apapun juga.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- 5) Jika **PIHAK KEDUA** memerlukan segala bentuk informasi atau keterangan medis atau *medical record* atas Peserta/Peserta, baik secara lisan maupun tertulis, maka **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA**, bahwa **PIHAK KEDUA** telah memiliki otoritas maupun izin dari Peserta/Pasien untuk keperluan tersebut. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul dikemudian hari, atas penyerahan informasi atau keterangan medis milik Peserta/Pasien kepada **PIHAK KEDUA** tersebut.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Segala perselisihan, persengketaan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian dan/atau segala sesuatu yang berhubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dengan tidak mengurangi hak **PARA PIHAK** untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas **PARA PIHAK**.
- 3) Bahwa Perjanjian Mediasi atau Putusan Arbitrase pada LAPS-SJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini bersifat mengikat bagi **PARA PIHAK** (final and binding) sebagaimana halnya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal **PARA PIHAK** telah memilih untuk menyelesaikan perselisihan melalui LAPS-SJK maka hak **PARA PIHAK** untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri dengan sendirinya gugur dan begitupun sebaliknya **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui LAPS-SJK dalam hal salah satu PIHAK telah mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas **PARA PIHAK**.

PASAL 14 KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali dipersyaratkan lain oleh hukum, maka:

- 1) **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** termasuk yang terafiliasi, subsidiari dan karyawan (kecuali bila diwajibkan oleh Undang-undang yang berlaku) baik sebelum maupun sesudah berakhirnya Perjanjian, wajib untuk tidak mengungkapkan data dan informasi-informasi rahasia yang berhubungan dengan data Klien atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kepada siapapun yang tidak diberi wewenang tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA**, maupun **PIHAK KEDUA** termasuk afiliasi, subsidiari, dan karyawan tidak berhak memberitakan/menyiarkan/mempromosikan Perjanjian baik secara lisan maupun tertulis kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, kecuali sebatas terdaftar sebagai klien.
- 3) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak berlaku, apabila :
- a. Informasi tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah Pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Informasi tersebut untuk keperluan Reasuransi, klaim dan Pihak *Third Party Administration (TPA)*.

PASAL 15 INSPEKSI DAN AUDIT

- 1) Salah satu Pihak setelah pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Pihak lainnya, dapat melakukan audit atau inspeksi catatan-catatan dan arsip-arsip terbatas dan hanya sehubungan dengan Perjanjian dan, atas biaya sendiri, membuat dan mengambil salinan-salinannya. **PARA PIHAK** harus senantiasa bekerja sama satu dengan lainnya dalam penyediaan informasi tersebut sebagaimana mungkin dibutuhkan secara layak oleh Pihak lainnya, dengan catatan bahwa akses tersebut tidak akan melanggar kerahasiaan atau Hukum Yang Berlaku.
- 2) **PIHAK PERTAMA** harus mengizinkan para pejabat yang sah dan berwenang dari Regulator Indonesia untuk melaksanakan inspeksi atau audit tersebut, sebagaimana dianggap layak oleh pihak Regulator di Indonesia atas catatan-catatan dan arsip-arsip yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan **PIHAK KEDUA** dan/atau produk-produk Asuransi.
- 3) **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan uji tuntas tahunan terhadap distributornya yang diharuskan berdasarkan kebijaksanaan perusahaannya dengan melengkapi dan mengembalikan formulir daftar pertanyaan uji tuntas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 16 PENCEGAHAN PENYUAPAN

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

- 1) **PARA PIHAK** telah mematuhi dan harus mematuhi semua hukum, aturan, peraturan, atau pembatasan mengikat lainnya oleh otoritas pemerintah, yang berlaku terhadap kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian dan telah memperoleh semua perizinan serta lisensi yang berlaku yang diperlukan dari **PARA PIHAK** sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan/atau Undang-Undang Anti Pencucian Uang (APU) dan/atau (ii) peraturan, hukum atau perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku.
- 2) **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa pihaknya mengetahui ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) serta tujuannya dan akan mematuhi dalam semua hal sehubungan dengan hukum, peraturan dan persyaratan administratif yang berlaku untuk hubungan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). **PIHAK PERTAMA** lebih lanjut menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan mengambil tindakan apapun yang akan menyebabkan **PIHAK KEDUA** melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).
- 3) **PIHAK PERTAMA** lebih lanjut menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada bagian dari kompensasi yang diterimanya berdasarkan Perjanjian akan dibayarkan atau dijanjikan untuk setiap Pejabat sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), atau kepada orang atau badan yang bertindak untuk Pejabat tersebut, dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan yang tidak wajar.

PASAL 17 GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan tanpa dapat dibatalkan, dicabut kembali atau diubah dengan alasan apapun dan dalam keadaan apapun, bahwa tidak pernah dan/atau tidak akan pernah memberikan dan/atau janji memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat kepada **PIHAK KEDUA** termasuk Para Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Karyawan dan/atau Para Keluarganya **PIHAK KEDUA** antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak (berupa benda berwujud maupun tidak berwujud)/tidak bergerak, hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti yang seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kerjasama dalam Perjanjian.

PASAL 18 ADDENDUM

- 1) Apabila salah satu Pihak menghendaki perubahan atas syarat dan ketentuan dalam Perjanjian, maka Pihak dimaksud wajib memberitahukan maksudnya kepada Pihak lainnya tentang perubahan tersebut secara tertulis dan disepakati oleh **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum syarat dan ketentuan dimaksud dinyatakan efektif berlaku.
- 2) Segala hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau hal-hal yang perlu dirubah dan/atau ditambah atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, maka akan diatur kemudian dalam Addendum/Amandemen, yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PASAL 19 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun Pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan Pihak tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
- 2) Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap Pihak lainnya telah melanggar Perjanjian apabila Pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan Perjanjian karena adanya Keadaan Memaksa.
- 3) Dalam hal timbulnya Keadaan Memaksa, Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut dengan disertai bukti yang dapat diterima oleh Pihak yang tidak mengalami Keadaan Memaksa, dan bilamana perlu harus menyertakan bukti-bukti yang sah dan asli dari instansi atau badan yang berwenang untuk itu.
- 4) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini, maka Keadaan Memaksa tidak akan diakui oleh Pihak lainnya, serta segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- 5) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, **PARA PIHAK** harus melakukan tindakan dan upaya yang sebaik-baiknya untuk mengatasi serta menanggulangi kerugian atau mencegah kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 20 PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat dan/atau komunikasi yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan kepada **PARA PIHAK** dalam bentuk surat atau faksimili ke alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit
Alamat : Jl. No.
Telp. /HP
Fax

Marketing
E-mail
Telp
Fax

Keuangan/Penagihan
Email
Telp. /HP
Fax

Kepala Kasir
Email
Telp. /HP

Pelayanan UGD : 021-...../Ext.....
Email

PIHAK KEDUA

PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA

Alamat : Citra Towers – North Tower 9th floor
Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6 Kemayoran, Jakarta 10630
Telp : (021) 3971-6789
No. Call Center : (021) 5313-2777

Provider Relation : Rini Pratiwi
Telp : (021) 3971-6789 ext 167
Mobile : 0812-1032-7614
E-mail : providerhealth1@cakrawalaproteksi.com

Finance : Veirent Audrew
Telp : (021) 3971-6789 ext. 1745
Mobile : 0812-1032-7391
Email : veirent.audrew@cakrawalaproteksi.com

Case Monitoring : Rismawani Purba
Telp : (021) 3971-6789 ext 165
Mobile : 0821-2260-5345
Email : case_monitoring@cakrawalaproteksi.com

Tagihan atas biaya pengobatan / pelayanan kesehatan peserta Asuransi Kesehatan Kumpulan ACPI dapat diajukan ke alamat pengiriman berikut:

- a. **PT ADMINISTRASI MEDIKA (ADMEDIKA)**
Telkom STO Gambir, Gedung C, Lantai 3,4,5
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12, Jakarta Pusat – 10110
Telp: 021-34831100
To: **Admedika – Asuransi Cakrawala Proteksi**
- b. **PT MEDILINK DIGITAL MEDIKA**
Rukan Sedayu City Boulevard Selatan Plus
Blok B Unit No. 33, 35 & 36, Cakung Barat
Cakung, Jakarta Timur 13910

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Telp: 021-50811080
To: **Asuransi Cakrawala Proteksi – Medilink**

Atau ke alamat lainnya yang dibuat dari waktu ke waktu, apabila ada perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang satu kepada Pihak yang lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal perpindahan.

- 2) Pemberitahuan, laporan, surat-menyurat dan atau komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini Ayat (1) dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui Kurir yang mempunyai izin yang sah.
 - b. Tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, dengan ketentuan seluruh lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya, sebagai buktinya adalah laporan pengiriman (transmittal/sending report) dengan status "OK". Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
 - c. Pos tercatat, sebagai bukti adalah resi pengiriman.
- 3) **PARA PIHAK** dengan ini menganggap dan menerima setiap faksimili yang diterima dari Pihak lainnya merupakan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan sederajat dengan asli surat.
- 4) Setiap penetapan atau penggantian atau perubahan pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus diberitahukan secara tertulis dari Pihak yang satu kepada Pihak yang lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sesudahnya dalam hal terjadinya perubahan.
- 5) Setiap penetapan atau perubahan ketentuan yang akan diberlakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan pelayanan Peserta **PIHAK KEDUA** harus diberitahukan secara tertulis dari Pihak yang satu kepada Pihak yang lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sesudahnya dalam hal terjadinya perubahan atau penetapan.

PASAL 21 PAJAK

PARA PIHAK sepakat untuk membayar seluruh kewajiban pembayaran pajak oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 22 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1) Lampiran-lampiran dari Perjanjian merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian;
- 2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat 1 pasal ini terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Third Party Administrator;
 - b. Lampiran II : Daftar Pengecualian Pelayanan;
 - c. Lampiran III : Contoh Kartu Peserta Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia
 - III.1 TPA ADMEDIKA
 - III.2 TPA MEDILINK
 - d. Lampiran IV : *Contact Person Emergency*

PASAL 23 LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal belum diatur dan/atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini, maupun perubahan yang perlu diadakan atasnya akan diatur dalam suatu Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mengikat **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan dan atau diubah tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- 3) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian;
- 4) Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya atau bubarnya badan hukum salah satu **PIHAK** tetapi akan diteruskan dan/atau akan beralih kepada badan pengganti atau penerusnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

PT
INDONESIA
(RUMAH SAKIT)

PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI

.....
Direktur
Tanggal:

Subagyo, SE As, AAIK, AMRP
Direktur Teknik
Tanggal:

DRAFT

LAMPIRAN I
THIRD PARTY ADMINISTRATOR

- 1) **PIHAK KEDUA** menyediakan layanannya kepada Peserta/Pasien menggunakan Jasa Pengelola Administrasi dari Pihak Ketiga (*Third Party Administrator/TPA*), maka pengertian **PIHAK KEDUA** dalam Klausul-klausul yang menyangkut prosedur pemberian Pelayanan Kesehatan dalam Perjanjian ini harus juga dibaca, dianggap dan/atau diartikan sebagai, atau ditujukan kepada Pengelola Administrasi dari Pihak Ketiga (*Third Party Administrator/TPA*).

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

2) **PIHAK KEDUA** menunjuk *Third-Party Administrator (TPA)* sebagai verifikasi/administrasi klaim, diantaranya:

a. PT ADMINISTRASI MEDIKA (ADMEDIKA)

AdMedika–Full TPA melalui sistem dan infrastruktur yang dimiliki sebagai jasa pengelolaan administrasi klaim untuk memeriksa keabsahan dan memasukkan data secara elektronik. Layanan yang diberikan oleh AdMedika kepada **PIHAK KEDUA** yaitu mulai dari proses administrasi sampai dengan pembayaran klaim.

Tagihan atas biaya pelayanan kesehatan peserta **PIHAK KEDUA** dengan AdMedika dapat diajukan ke alamat berikut:

PT ADMINISTRASI MEDIKA (ADMEDIKA)

Telkom STO Gambir, Gedung C, Lantai 3,4,5
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12, Jakarta Pusat – 10110

Telp: 021-34831100

To: **Admedika – Asuransi Cakrawala Proteksi**

b. PT MEDILINK DIGITAL MEDIKA (MEDILINK)

Medilink sebagai verifikasi/administrasi klaim, sedangkan tanggung jawab pembayaran atas biaya pelayanan Kesehatan peserta **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Rumah Sakit/Klinik (ACPI sebagai Payor).

Tagihan atas biaya pelayanan kesehatan peserta **PIHAK KEDUA** dengan Medilink dapat diajukan ke alamat berikut:

PT MEDILINK DIGITAL MEDIKA

Rukan Sedayu City Boulevard Selatan Plus
Blok B Unit No. 33, 35 & 36, Cakung Barat

Cakung, Jakarta Timur 13910

Telp: 021-50811080

To: **Asuransi Cakrawala Proteksi – Medilink**

3) Kartu Peserta (Kartu Kesehatan Jaringan Elektronik) adalah kartu asuransi kesehatan atas PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) – yang dikeluarkan oleh AdMedika dan/atau Medilink, dan diberikan kepada Peserta sebagai identitas kepesertaan yang digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan fasilitas Pelayanan/Perawatan Kesehatan pada *Provider* sesuai manfaat asuransi kesehatan yang menjadi hak Peserta.

4) Ruang Lingkup Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Admedika dan Medilink meliputi:

a) Policy Services

b) Manajemen Klaim

i. Layanan Proses Klaim Provider

ii. Layanan Proses Klaim *Reimbursement*

5) *Call Center dan Case Monitoring*

a) ADMEDIKA

i. *Help Line* 24 Jam : 021–29275158

ii. *Case Center* 7/24 Jam : 0812–8102–6032 (Dedicated Line AdMedika)

iii. Email : customer.care@admedika.co.id

b) MEDILINK

i. *Help Line* 24 Jam : 021–50811081

ii. Emergency 24 Jam : 0878–6444–8107

iii. Email : customercare@medilink.co.id

c) ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA (ACPI)

i. Hotline : 0821–2260–5345 (*Case Monitoring*)

ii. Email : case.monitoring@cakrawalaproteksi.com

**LAMPIRAN II
PENGECUALIAN**

Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar Manfaat Asuransi untuk Penyakit dan/atau Cedera, perawatan dan/atau pengobatan, atau biaya-biaya lain yang termasuk dalam pengecualian ini, kecuali dinyatakan lain melalui Ketentuan Khusus yang diterbitkan oleh Penanggung.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Daftar pengecualian Polis ini adalah:

- 1) **BIAYA-BIAYA NON MEDIS DAN/ATAU YANG TIDAK DIPERLUKAN SECARA MEDIS**
 - a. Produk yang dibeli secara bebas atau tidak Diperlukan Secara Medis termasuk: sabun mandi, *tissue*, pembalut, bedak, obat kumur, pasta gigi, sikat gigi, obat gosok, susu (kecuali susu rendah laktosa untuk anak penderita diare yang sedang Perawatan Menginap), dan makanan bayi.
 - b. Fasilitas tambahan yang disediakan oleh Rumah Sakit untuk kenyamanan seperti: penggunaan telepon, faks, *laundry*, salon, makanan tambahan, dan lain-lain.
 - c. Pemberian obat-obatan yang dibeli di luar Apotek dan/atau vitamin/multivitamin dan suplemen yang tidak Diperlukan Secara Medis dan tidak berhubungan dengan Penyakit dan/atau Cedera yang diderita Peserta termasuk vitamin dan multivitamin yang dipasarkan melalui cara *Multilevel Marketing (MLM)*.

Penyakit-penyakit di bawah ini termasuk komplikasinya:

- a. Penyakit menular seksual dan Penyakit yang timbul akibat hubungan seksual;
- b. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrom*) dan ARC (*AIDS Related Complex*);
- c. Disfungsi seksual, *micro penis*, ejakulasi dini, impotensi, frigiditas;
- d. Penyakit jiwa/Penyakit mental lainnya, termasuk segala jenis neurosis dan psikosis, manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatis, gangguan kepribadian, dan gangguan tidur;
- e. Gangguan tumbuh kembang seperti gangguan wicara, autisme, *down syndrome*, dan ADHD;
- f. Hernia pada Peserta yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun;
- g. Komplikasi yang ditimbulkan akibat tindak, *tattoo* dan sejenisnya;
- h. *Fatigue*, lelah mata, lelah mental atau lelah fisik termasuk istirahat untuk pemulihan atau perawatan di sanatorium;
- i. Penyakit hereditas namun terbatas pada: *thalasemia*, *haemophyllia*, katarak pada anak, PTC, *dentinogenesis cystinuria* dan albino.

2) **KELAINAN BAWAAN / CACAT KONGENITAL**

Semua perawatan atau Pembedahan terhadap Kelainan Bawaan/Cacat Kongenital (Penyakit yang dibawa sejak lahir), serta komplikasi yang ditimbulkannya, antara lain: *atresia ani*, VSD, ASD, bibir sumbing, septum deviasi, cacat tulang, *debil*, *embicil*, *mongoloid*, *cretinism*, *hydrocephalus*, *mamma aberans*, *hemangioma*, *limfangioma*, *andescencus testis*, Penyakit yang ditularkan dari ibu saat masih dalam kandungan, dan lain-lain.

3) **AKIBAT AKTIVITAS BERBAHAYA**

Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung dari:

- a. Peperangan baik yang dinyatakan maupun tidak, mengemban tugas militer, keikutsertaan secara langsung dalam huru-hara, pemogokan dan pergolakan sipil atau pemberontakan, teroris;
- b. Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh Peserta/Tertanggung dan/atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam Polis asuransi ini;
- c. Usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan sendiri;
- d. Ikut serta dalam aktivitas berbahaya seperti panjat tebing, panjat gedung, mendaki gunung, berburu dan lain-lain;
- e. Ikut serta dalam lomba adu kecepatan dengan kendaraan bermesin seperti balap motor, balap mobil, balap perahu dan lain-lain;
- f. Segala aktivitas terbang di udara dan menyelam yang menggunakan alat bantu pernapasan seperti terjun payung, terbang layang, *sky diving*, *ultralite*, *diving* dan lain-lain;
- g. Keikutsertaan dalam kejuaraan yang dilakukan secara profesional;
- h. Keikutsertaan dalam penerbangan non komersial/tidak terjadwal seperti pesawat udara carteran, helikopter, militer/polisi;
- i. Terpapar radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan-bahan senjata nuklir.

4) **MASALAH HORMONAL REPRODUKSI DAN UPAYA MEMILIKI KETURUNAN**

Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan:

- a. Kesuburan (infertilitas), segala pengujian dan perawatan kemandulan, dan usaha untuk mendapatkan keturunan baik dengan cara bayi tabung, inseminasi, hidrotubasi, Pembedahan untuk Penyakit penyebab ketidaksuburan atau pengobatan gangguan hormonal terkait ketidaksuburan, dan akibat-akibat yang ditimbulkan karena pengobatan-pengobatan tersebut di atas;
- b. Kontrasepsi untuk pengaturan kehamilan secara mekanis atau kimiawi, sterilisasi baik itu kastrasi, tubektomi dan vasektomi;

5) **PENGobatan / PERAWATAN MEDIS NON STANDAR**

Perawatan dan/atau Pengobatan yang bersifat eksperimental serta pelayanan kesehatan yang belum diakui sebagai pengobatan medis standar di bidang kedokteran (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), antara lain: pijat, dukun, ramuan tradisional, jamu, akupunktur oleh *sinshe*, akupresur, terapi ozon, terapi *hyperbaric*, *hydroterapi*, *chiropractic*, *mesotherapy*, *laser therapy (lasic)* untuk koreksi refraksi dan pengobatan lain yang sejenis.

6) **PENGobatan / PERAWATAN KOSMETIK**

Perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan tujuan estetika termasuk operasi plastik atau Pembedahan/perawatan kosmetik (kecuali bedah plastik rekonstruksi akibat Kecelakaan yang dilakukan 31 (tiga puluh satu) hari kalender setelah Kecelakaan), Pembedahan mata dengan laser untuk koreksi refraksi (metode

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

lasik), perawatan khusus untuk pengurangan atau penambahan berat badan dan peningkatan tinggi badan, tindakan dan perawatan *orthodontic*.

- 7) PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK TUJUAN PENCEGAHAN ATAU *SCREENING TEST*
Medical Check-up, tes-tes yang tidak berhubungan langsung dengan pengobatan atau diagnosa kondisi yang dijamin, pemeriksaan yang tidak Diperlukan Secara Medis termasuk *Obstructive Sleep Apnea* (OSA), tes dengan tujuan *screening* seperti pemeriksaan TORCH, uji hepatitis, *mammography*, *pap smear*, uji alergi, dan lain-lain.
- 8) ALAT-ALAT BANTU
Biaya pembelian alat-alat bantu kesehatan antara lain:
a. Alat-alat bantu prothesa gerak, prothesa mata, alat bantu dengar (*hearing aid*), dan alat bantu sejenisnya.
b. Alat-alat bantu penunjang seperti; semua jenis korset, *stocking*, kruk, kursi roda, *servical collar*, *armsling*, dan alat bantu sejenisnya.
- 9) SUNAT (SIRKUMSISI)
Tindakan sunat (sirkumsisi) oleh sebab apapun untuk Peserta sesuai indikasi medis.
- 10) TRANSPLANTASI ORGAN
Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan transplantasi organ termasuk pembelian organ.
- 11) Perawatan dan/atau pengobatan yang terkait tindakan kriminal/tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Peserta/Tertanggung dan/atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam Polis asuransi ini, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kecanduan obat, penggunaan alkohol, pemakaian narkotik, obat bius dan sejenisnya.
- 12) Perawatan yang telah mendapatkan penggantian secara penuh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan/atau perusahaan asuransi lain (untuk *Coordination of Benefit* BPJS).
- 13) Perawatan yang dilakukan oleh keluarga/kerabat dekat atau oleh orang yang biasa tinggal satu rumah dengan Peserta.
- 14) Pengobatan/perawatan rawat jalan oleh Dokter Umum, Dokter Spesialis, kecuali jika Peserta terdaftar pada jaminan Manfaat Asuransi "Rawat Jalan".
- 15) Persalinan, keguguran kandungan, pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan setelah persalinan termasuk segala komplikasi yang terjadi akibat persalinan, kecuali jika Peserta terdaftar pada jaminan Manfaat Asuransi "Perawatan Kehamilan dan Persalinan".
- 16) Pemeriksaan, pencabutan atau penambahan gigi dan perawatan gigi yang bersifat umum bukan akibat Kecelakaan serta pemasangan gigi palsu, kecuali Peserta terdaftar pada jaminan Manfaat Asuransi "Rawat Gigi".

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN III
CONTOH KARTU ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA

III. 1. TPA ADMEDIKA

A. TAMPAK DEPAN



B. TAMPAK BELAKANG



III. 2. TPA MEDILINK

A. TAMPAK DEPAN



B. TAMPAK BELAKANG



Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN IV
CONTACT PERSON EMERGENCY

PIHAK PERTAMA

BAGIAN	NAMA	TELP		EMAIL
		HP	KANTOR	
Pelayanan Medis				
Pemasaran & Pengelolaan Pelanggan				
Administrasi Rawat Inap				
Administrasi Rawat Jalan				
Penagihan				
Rekam Medis				
Farmasi				
Legal				
Instalasi Gawat Darurat (IGD)				
Pendaftaran Rawat Inap (RRI)				
Pendaftaran Rawat Jalan (Customer Care Center)				
Administrasi Rawat Inap				
Billing Sementara, Surat Jaminan Pasien Rawat Inap, Informasi Pasien Rawat Inap, Konfirmasi Kepulangan Pasien				
Administrasi Rawat Jalan				
Surat Jaminan Pasien Rawat Jalan, Informasi Pasien Rawat Jalan				
Penagihan				
Rekam Medis				
Rekam Medis Pasien, Pengisian Formulir Klaim				

PIHAK KEDUA

BAGIAN	NAMA	TELP		EMAIL
		HP	KANTOR	
Case Monitoring	Persetujuan tindakan	082122605345	(021) 29275158	case.monitoring@cakrawalaproteksi.com
	Permintaan surat jaminan	081281026032		
Provider Health	Rini Pratiwi	081210327614	(021) 39716789 ext 167	providerhealth1@cakrawalaproteksi.com
Keuangan	Veirent Audrew	081210327391	(021) 39716789 ext. 1745	veirent.audrew@cakrawalaproteksi.com

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua